

T8.16 Tabeller

Risikofaktorer

- 1. hjertesvikt
- 2. hypertensjon
- 3. alder 65–75 år
- 4. alder > 75 år
- 5. diabetes
- 6. tidl.slag/TIA
- 7. karsykdom
- 8. kvinner

Antall poeng (p)

- 1. 1 p
- 2. 1 p
- 3. 1 p
- 4. 2 p
- 5. 1 p
- 6. 2 p
- 7. 1 p
- 8. 1 p
- a. Skår ≥ 2 hos menn eller ≥ 3 hos kvinner: antikoagulasjonsbehandling anbefalt
- b. Skår=1 hos menn eller =2 hos kvinner: antikoagulasjonsbehandling valgfri beroende på blødningsfare og pasientens preferanse
- c. Skår=0 hos menn eller =1 hos kvinner: antikoagulasjonsbehandling ikke anbefalt

Tabell 3 CHA2DS2-VASc

Anbefalinger for bruk av antitrombotisk behandling ved atrieflimmer basert på europeiske 2016-retningslinjer. (INR= internasjonalt normalisert ratio) DOAK (direktevirkende oral antikoagulasjon))

Generelle retningslinjer

- Peroral antikoagulasjonsbehandling med [warfarin](#) (INR 2,0–3,0) eller DOAK anbefales ved CHA2DS2-VASc-skår ≥ 2 hos menn eller ≥ 3 hos kvinner
 - Ved CHA2DS2-VASc-skår = 1 hos menn eller =2 hos kvinner, kan man vurdere [warfarin](#), DOAK eller ingen antikoagulasjonsbehandling, ut fra vurdering av blødningsrisiko og pasientens preferanse.
 - Ved CHA2DS2-VASc-skår = 0 anbefales hverken [warfarin](#) eller DOAK med mindre det er i forbindelse med planlagt elektrokonvertering eller kateterablasjon
 - ASA har ingen plass som profylakse mot emboli og hjerneslag ved atrieflimmer (men kan fortsatt benyttes i forbindelse med koronarsykdom)
 - Anbefalingene gjelder uavhengig av om arytmien er anfallsvis eller vedvarende
 - Samme anbefalinger gjelder for atrieflutter
-

Anbefalinger for bruk av antitrombotisk behandling ved atrieflimmer basert på europeiske 2016-retningslinjer. (INR= internasjonalt normalisert ratio) DOAK (direktevirkende oral antikoagulasjon))

Elektrisk eller medikamentell konvertering

- Elektiv konvertering av atrieflimmer av > 48 timers eller usikker varighet
 - Peroral antikoagulasjon med [warfarin](#) (INR 2,0–3,0) eller DOAK i minst tre uker før konvertering. Antikoagulasjon fortsettes minst 4 uker etter konvertering.
 - Hvis øsofagusekko utelukker atrie trombe, kan man elektrokonvertere pasienten under dekke av heparin (ufraksjonert eller lavmolekylært) eller DOAK. Antikoagulasjonsbehandling fortsettes minst 4 uker etter konvertering. Hvis pasienten skal bruke [warfarin](#) denne perioden, må heparin-behandlingen kontinueres til man har nådd terapeutisk INR-nivå.
- Ved konvertering av atrieflimmer som med rimelig sikkerhet har vart < 48 timer
 - Konvertering kan gjøres uten forutgående antikoagulasjonsbehandling
 - Hos pasienter med risikofaktorer (CHA₂DS₂-VASc) anbefales samme antikoagulasjonsbehandling som beskrevet i forbindelse med øsofagusekko ovenfor, i minst 4 uker (CHA₂DS₂-VASc = 1), ev. på ubestemt tid (CHA₂DS₂-VASc ≥ 2), selv ved konvertering innenfor 48 timer.
- DOAK er kontraindisert ved sterkt nedsatt nyrefunksjon. Kreatininclearance bør kontrolleres årlig, og hyppigere hos gamle og ved påvist redusert nyrefunksjon. Det er individuelle forskjeller mellom ulike DOAK i hvilken grad de kan benyttes ved moderat nedsatt nyrefunksjon.

Tabell 4 Anbefalinger for bruk av antitrombotisk behandling ved atrieflimmer